



**FACULTAD DE OBSTETRICIA Y ENFERMERÍA
HILDA ZORAIDA BACA NEGLIA**

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA

PLAN DE TESIS

**PERCEPCIÓN DEL PACIENTE SOBRE LA CALIDAD DEL CUIDADO
DE ENFERMERÍA EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE
TUBERCULOSIS DEL C.S MAX ARIAS SCHREIBER, 2024**

PARA OPTAR

TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN ENFERMERÍA

**PRESENTADO POR:
ELENA DURAN LANDA**

**ASESORA
DRA. KARIN ROCÍO PEREYRA VIVAR**

LIMA, PERÚ

2024

INDICE DE CONTENIDOS

	Págs.
Portada	i
Índice	ii
CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	3
1.1 Descripción de la situación problemática	3
1.2 Formulación del problema	6
1.3 Objetivos de la investigación	7
1.4 Justificación de la investigación	8
1.4.2 Viabilidad del estudio	9
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO	11
2.1 Antecedentes de la investigación	11
2.2 Bases teóricas	13
CAPÍTULO III: HIPÓTESIS Y VARIABLES	21
La investigación no presenta hipótesis.	21
3.2 Variables y definición operacional	21
CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA	25
4.1 Diseño metodológico	25
4.2 Diseño muestral	25
4.3 Técnica de recolección de datos	26
4.4 Técnicas estadísticas para el procesamiento de la información	27
4.5 Aspectos éticos	28
CRONOGRAMA	36
PRESUPUESTO	37
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	38
ANEXOS	44

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Descripción de la situación problemática

La tuberculosis es una de las enfermedades transmisibles que ha cobrado el buen estado de salud físico y mental de la población, siendo el medio de transmisión la vía aérea. Por otro lado, las personas que tienen la bacteria en el organismo, pero aún no presentan los síntomas no van a contagiar¹.

Cabe recordar que la tuberculosis se puede prevenir y curar si se cumplen con el tratamiento oportuno. La transmisión de la tuberculosis es cuando la persona afectada por TB sin tratamiento se da cuando el paciente tose, habla o estornuda¹.

Según la (OMS)² Organización Mundial de la Salud, nos informa que se ha calculado que, en el 2022, se enfermaron de tuberculosis 10.6 millones de personas de las cuales, 1.3 millones fallecieron (entre ellas 167 000 con VIH). En tanto en la Región de Asia Sudoriental de la OMS se registró el 46% de nuevos casos, seguido de la Región de África (23%) y la Región del Pacífico Occidental (18%).

Mientras tanto en las Américas, según (OPS)³ Organización Panamericana de la Salud, nos indica que en 2020 se observó un descenso respecto a la notificación de casos de TB de un 16.8% en relación al 2019 dando como resultado final de 291 000 casos; siendo Brasil, Perú y México los países con

alta carga de tuberculosis con un 33%, 13.1% y 10.7% respectivamente por otro lado Dominica y Guyana con menor carga con un (0% y 0.2%).

Según MINSA⁴, nos informa que, en el 2022, el incremento de casos nuevos es en la edad de 40 a 80 años, donde se tuvo 34.32% por 100 mil habitantes, siendo el primer lugar Lima Centro (76.62%), seguido de Loreto (75.72%), por lo contrario, el menor porcentaje lo tiene Pasco con (4.83%) de casos.

El campo de la salud ocupacional o salud en el trabajo es complejo y requiere la atención de diferentes disciplinas que coadyuven al cumplimiento de su misión. En esta área como en otras, la enfermería cumple la noble función bajo la perspectiva fundamental de la prevención y la promoción de la salud antes que el enfoque meramente curativo y por ello, su aporte es trascendental⁵.

Como indica la (OMS)⁶ Organización Mundial de la Salud define la calidad de atención como el grado en el que los servicios de salud para personas y poblaciones aumentan la probabilidad de resultados de salud deseados, del mismo modo indica que la atención se basa en conocimientos profesionales que están basados en evidencia y es fundamental con el fin de lograr una cobertura sanitaria universal.

Por otro lado, la ISO explica que una atención de calidad para todos promueve la igualdad para gozar de una buena salud, independientemente de su situación socioeconómica⁷.

Durante mi experiencia como interna de enfermería en el Centro de Salud Max Arias Schreiber, en el año 2023, en el servicio de programa de control de tuberculosis, pude observar que los pacientes que acudían por su tratamiento, tenían ciertas preferencias por algún personal de enfermería

mientras que otros simplemente decían comentarios negativos hacia la atención brindada por el personal de salud.

Así mismo se quejaban de la poca información que se le brindaba a la hora de iniciar su tratamiento, en caso de ser paciente nuevo, en las visitas domiciliarias muchas veces no se brindaba información adecuada.

De igual modo al interactuar con los pacientes, ellos referían: “A veces la enfermera está realizando audiometrías y tengo que esperar para que me atienda” “cuando le digo que me da nauseas solo me dicen que es por los medicamentos” “al costado del programa hay personas de mal vivir que se ponen a fumar y ese humo molesta”

Es por ello que se ve la necesidad de estudiar cual es la percepción del paciente sobre la calidad del cuidado de enfermería en el programa de control de tuberculosis.

1.2 Formulación del problema

PROBLEMA GENERAL

¿Cuál es la percepción del paciente sobre la calidad del cuidado de Enfermería en el Programa de Control de Tuberculosis del CS Max Arias Schreiber 2024?

PROBLEMAS ESPECIFICOS

1. ¿Cuál es la percepción del paciente sobre la calidad del cuidado de Enfermería en el Programa de Control de Tuberculosis en su dimensión interpersonal del CS Max Arias Schreiber 2024?
2. ¿Cuál es la percepción del paciente sobre la calidad del cuidado de Enfermería en el Programa de Control de Tuberculosis en su dimensión técnica del CS Max Arias Schreiber 2024?
3. ¿Cuál es la percepción del paciente sobre la calidad del cuidado de Enfermería en el Programa de Control de Tuberculosis en su dimensión entorno del CS Max Arias Schreiber 2024?

1.3 Objetivos de la investigación

Objetivo general

Determinar la percepción del paciente sobre la calidad del cuidado de Enfermería en el Programa de Control de Tuberculosis del CS Max Arias Schreiber 2024.

Objetivos específicos

1. Identificar la percepción del paciente sobre la calidad del cuidado de Enfermería en el Programa de Control de Tuberculosis en su dimensión interpersonal en el CS Max Arias Schreiber 2024.
2. Identificar la percepción del paciente sobre la calidad del cuidado de Enfermería en el Programa de Control de Tuberculosis en su dimensión técnica en el CS Max Arias Schreiber 2024.
3. Identificar la percepción del paciente sobre la calidad del cuidado de Enfermería en el Programa de Control de Tuberculosis en su dimensión entorno en el CS Max Arias Schreiber 2024.

1.4 Justificación de la investigación

1.4.1 Importancia de la investigación

Como finalidad, en el presente estudio de investigación, se procura determinar la percepción del paciente sobre la calidad del cuidado de enfermería en el programa de control de tuberculosis, así como reconocer algunas deficiencias que hay por parte del personal de salud, según comentarios de los pacientes.

Porque a través de este estudio mencionaremos cuales son las medidas que debe alcanzar el personal de enfermería para brindar una atención de calidad y así contribuir en la disminución de percepciones negativas por parte de los pacientes.

Para que, mediante esto, se beneficie a toda la población que se atiende en el Centro de Salud Max Arias Schreiber, ya que al contar con un personal capacitado no solo en el tratamiento antituberculoso sino también en el trato personalizado, el entorno y las diferentes técnicas harán que el paciente se sienta cómodo y no abandone su tratamiento.

A si mismo servirá como un nuevo antecedente para futuras investigaciones que contengan variables similares.

1.4.2 Viabilidad del estudio

Temporal

El estudio se realizará en el año 2024. La encuesta percepción del paciente sobre la calidad del cuidado de enfermería en el programa de control de tuberculosis, para la recolección de datos se obtendrá en el horario de atención, lunes a sábado de 7:00 – 13:00 pm.

Espacial

Las instalaciones donde se realizarán el cuestionario percepción del paciente sobre la calidad del cuidado de enfermería en el programa de control de tuberculosis, serán en el Centro de Salud Max Arias Schreiber MINSA localizado en Jr. Antonio Raimondi 206, La Victoria, de la ciudad de Lima.

Recursos

Para la elaboración del estudio de investigación se tiene en cuenta con recursos humanos (encuestador, asesor de estadística, USB) y recursos económicos (fotocopias, impresiones, internet, entre otros).

1.5 Limitaciones de estudio

Las limitaciones que tendré durante este estudio será que, no todos los pacientes llegan al centro para su tratamiento, pues algunos faltan ya sea por trabajo o porque se le complica ir dentro del horario de atención del centro, el cual solo es hasta las 13:00pm, en otros casos como los adultos mayores y personas con discapacidad para trasladarse solos, envían a familiares o vecinos a recoger su tratamiento correspondiente.

Además, como dice en el consentimiento informado la participación es voluntaria y puede haber pacientes que no deseen participar o se retiren antes de culminar el cuestionario.

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes de la investigación

A nivel nacional

Olivares⁸, en 2024, publicó una investigación sobre “Percepción del paciente con tuberculosis sobre la interrelación enfermera-paciente en un Centro de Salud de Lima”. Su metodología fue: de enfoque cuantitativo, con un diseño descriptivo y corte transversal; el diseño fue no experimental. Sus resultados fueron, el 88% (53) tienen una percepción favorable respecto a la interrelación de enfermera - paciente mientras que 12% percepción medianamente favorable.

García⁹, en 2020, investigó en su tesis: “Percepción de los pacientes en tratamiento de tuberculosis acerca del cuidado que brinda el profesional de enfermería en la estrategia sanitaria nacional de prevención y control de tuberculosis del Centro de Salud Materno Infantil, Los Sureños”. Su metodología fue: estudio descriptivo de enfoque cuantitativo, no experimental. Sus resultados fueron, que del total de pacientes que fueron encuestados el 59% (16) tiene una percepción medianamente favorable acerca del cuidado que brinda el profesional de enfermería, el 34% (11) tiene percepción favorable y el 16% (5) una percepción desfavorable.

Condori¹⁰, en 2020, realizó una tesis a la que tituló: “Percepción del paciente sobre calidad de atención del equipo del programa de control de tuberculosis del Hospital Jerusalén 2019”. Su metodología, fue de naturaleza no

experimental, de enfoque cuantitativo y diseño descriptivo. Sus resultados fueron que el 82,7% de los pacientes diagnosticados con tuberculosis manifestaron que la calidad de atención en el mencionado hospital es buena y solo el 17.3% percibieron una atención regular.

A nivel internacional

Vásquez¹¹, en 2023, en Ecuador, publicó una investigación sobre “Percepción de la calidad de atención del programa de tuberculosis DOTS de pacientes adultos del Centro de Salud Tipo C La Troncal”. Su metodología fue, un tipo de estudio observacional, descriptivo, de corte transversal con enfoque cuantitativo. Sus resultados fueron: que perciben como buena en la atención ya que logró una puntuación general de 4,10/5 lo que indica que el servicio cumple satisfactoriamente con las necesidades y expectativas del paciente.

Mariani et al¹², en Argentina el 2020, publicó una investigación sobre “Percepción de los pacientes respecto al cuidado de enfermería”. Su metodología fue un estudio observacional transversal. Sus resultados fueron que: no hubo diferencias significativas en los dominios ni los puntajes globales entre grupos. Los participantes con TB dieron menores puntajes en todos los dominios, excepto en enfoque familiar que fue significativamente mayor que los de los participantes NoTB; el puntaje global sin dominios secundarios fue menor en los participantes con TB que en los NoTB. Según la percepción de los participantes con TB y sin TB, las funciones de la atención primaria de salud no son satisfactorias, tanto dentro de las villas de emergencia como fuera de ellas.

2.2 Bases teóricas

Teoría de las relaciones interpersonales

Hildegard Peplau¹³ es una enfermera que creó una teoría llamada “teoría de las relaciones interpersonales” pues en ella nos explica cómo la relación entre enfermero – paciente debe fluir para el bienestar y mejora de su salud físico y psíquico, esta se va a dar en cuatro fases con el fin del desarrollo de ambos en diferentes entornos:

- Primera fase (orientación): es cuando el paciente presenta un estado de incomodidad y necesita la ayuda de un profesional de enfermería, quien lo va ayudar a entender lo que está pasando¹³.
- Segunda fase (identificación): aquí el paciente reconoce que necesita ayuda y colabora con la enfermera, mientras este va formando el diagnóstico para crear un plan de acción¹³.
- Tercera fase (explotación): es cuando el plan de cuidados que se realiza de manera efectiva y el paciente hace uso de los servicios y colabora para su beneficio¹³.
- Cuarta fase (resolución): es la parte donde los objetivos empiezan a lograrse positivamente, además la relación y comunicación entre enfermero – paciente se va fortaleciendo y haciendo independiente¹⁴.

El desarrollo de estas fases fue adoptado por todos los profesionales de enfermería ya que ofrece un método para formar un modelo basado en teoría y práctica para promover una relación y hallar soluciones a una necesidad insatisfecha¹³.

Entrevista de enfermería

Como seres humanos que somos nos comunicamos constantemente ya sea de manera verbal o no verbal a través de gestos y pues como profesionales de enfermería el saber comunicarse es muy importante para poder establecer una relación terapéutica de confianza y efectiva con los pacientes que atendemos, teniendo en cuenta algunos aspectos psicológicos, sociales y biológicos¹⁴.

Es así que definimos a la entrevista, como una herramienta que nos permite acercarnos al paciente y su entorno a través de la comunicación efectiva con el objetivo de conseguir información necesaria para ayudar en el tratamiento y por ende en la mejoría de su salud. Demos recalcar que este tipo de comunicación es con fines terapéuticos y no mal intencionados¹⁴.

Definición de Tuberculosis

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por el bacilo tuberculoso, una bacteria que afecta a los pulmones, este se propaga por el aire cuando una persona infectada tose, estornuda, escupe o habla².

Epidemiología

Se estima que alrededor de la cuarta parte de la población esta infectada y tal vez unos 15 millones de personas tengan la enfermedad activa en algún momento, por otro lado, se dice que la incidencia de casos va a variar según el país, la edad, la raza, el sexo y el estado socioeconómico¹⁵.

Sin embargo, en algunas partes del mundo la tuberculosis resistente a rifampicina u otros fármacos no puede diagnosticarse con rapidez y brindar un tratamiento oportuno¹⁵.

Etiología

El contagio de *Mycobacterium tuberculosis* generalmente se produce por vía aérea, esto ocurre cuando los pacientes expulsan el bacilo de Koch, a través de la tos o el estornudo, estas partículas pueden permanecer durante un tiempo suspendidas en el aire, lo que aumenta el riesgo de que las personas sanas se contagien al tener un contacto cercano¹⁶.

Por otro lado, la capacidad de contagio va a depender del tipo de cepa de *M. Tuberculosis*, esto incluye los factores ambientales y el tratamiento oportuno ya que a pocos días de haber iniciado ya no contagia, pero cabe mencionar que un tratamiento incompleto o cumplimiento deficiente puede desencadenar a resistencias farmacológicas a través de mutaciones genéticas ¹⁶.

Manifestación clínica

Los síntomas habituales de la tuberculosis son²:

- Tos prolongada (a veces con sangre)
- Dolor torácico
- Astenia
- Cansancio
- Pérdida de peso
- Fiebre
- Sudores nocturnos

Estos síntomas van a depender de la parte del cuerpo en la que se encuentre activa la tuberculosis².

Factores de riesgo

Las personas con infección latente casi siempre no se sienten enfermas ni transmiten el bacilo, pues solo un pequeño porcentaje se enferma y tendrá síntomas. Los que tienen mayor riesgo de enfermarse son los niños y bebés.

Algunos factores pueden aumentar el riesgo de contraer la tuberculosis²:

- Diabetes
- VIH
- Malnutrición
- Consumo de tabaco

Diagnóstico

Las pruebas de diagnóstico para la tuberculosis en los establecimientos de salud incluyen¹⁷:

- Análisis de esputo: Consta de recolectar una muestra de esputo y examinarla para identificar la bacteria que causa la tuberculosis, los resultados estarán listos en unos días dependiendo el tipo de análisis que se haga (molecular o baciloscopia)¹⁷.
- Radiografía de tórax: Consiste en tomar imágenes de los pulmones con rayos X para buscar señales como manchas oscuras o áreas anormales que indiquen presencia de la enfermedad¹⁷.
- Cultivo: Se utiliza para detectar la presencia de la bacteria en muestras biológicas¹⁷.
- Análisis clínico: En este caso el médico va a evaluar los síntomas que está presentando el paciente, los resultados de las radiografías, antecedentes clínicos e incluso biopsias si es el caso¹⁷.

Cabe recalcar que todos los exámenes para diagnóstico de tuberculosis son gratuitos a nivel nacional en los establecimientos de salud¹⁷.

Métodos moleculares rápidos

Hasta antes del 2007, el diagnóstico de la tuberculosis se basaba en baciloscopia y el cultivo, es por ello que dio la necesidad de contar con diagnósticos más rápidos y sensibles donde nos permitan conocer la resistencia de los enfermos. Algunos de las pruebas ya son recomendadas por la OMS¹⁸:

1. Xpert MTB/Rif: Es recomendada por la OMS desde el 2010, ya que tiene una reacción en cadena de polimerasa (PCR) capaz de detectar la presencia de *M. tuberculosis* y la resistencia a la rifampicina (TB-RR) en un plazo de 2 horas¹⁸.

La sensibilidad en muestras pulmonares de adultos es de 88% para BK (+), 68% para BK (-) y 79% para pacientes VIH (+) con una especificidad de 99%. Por otro lado, en niños su sensibilidad es de 66% con una especificidad de 98%¹⁸.

TIPOS DE TUBERCULOSIS

La tuberculosis principalmente afecta a los pulmones, pero también se diseminan a otras partes del cuerpo a través del torrente sanguíneo¹⁶.

- Tuberculosis pulmonar: Es la forma más frecuente que afecta a los pulmones y mas del 80% de los casos pertenecen a este tipo. Este tipo de tuberculosis suele ser contagiosa¹⁶.
- Tuberculosis extrapulmonar: Es el tipo de tuberculosis que aparece fuera de los pulmones, puede ser a causa de la diseminación

hematógena de la infección, a veces se extiende de un órgano adyacente y los síntomas van a variar según su localización¹⁹.

En este caso afecta con mayor frecuencia a la pleura, ganglios linfáticos, huesos o articulaciones, el aparato genitourinario, sistema nervioso y el abdomen. Este tipo de tuberculosis no suele ser contagiosa²⁰.

2.3 Definición de términos básicos

2.3.1 PERCEPCION

La percepción se puede definir como un proceso basado en organizar, interpretar e identificar toda la información sensorial que se recibe para entender los datos de nuestro entorno²¹.

Comentado [C1]: Revise este ítems, es definición de términos.

2.3.2 Calidad del cuidado de enfermería

La calidad de los cuidados de enfermería es atender las necesidades de salud, procurando brindar el más alto grado de satisfacción y expectativas por parte de los pacientes²².

Por otro lado, la sobre carga de trabajo en el hospital de atención primaria, puede llegar afectar la calidad del cuidado de enfermería que proporciona a los pacientes, ya que al tener mayor demanda no se podrá realizar un cuidado optimo ni satisfacer las necesidades de cada uno, por ello es necesario mantener el equilibrio entre la carga de trabajo y dotación personal²³.

2.3.3 Dimensión interpersonal

En enfermería se establecen relaciones con el paciente y sus familiares, de este modo se podrá favorecer la salud del paciente satisfaciendo sus necesidades mediante cuidados de enfermería²⁴.

Entonces podemos decir que para una rápida recuperación del paciente es muy importante que haya buena comunicación entre enfermero – paciente. Además, el profesional de enfermería debe de mostrar la información correcta que sea entendible para el paciente, por otro lado, se debe respetar la cultura y las costumbres que tienen, siempre mostrando amabilidad y empatía²⁴.

2.3.4 Dimensión técnica

La relación entre el personal de enfermería y el paciente se basa en una comunicación plenamente humana, donde se requiere tiempo, comprensión y trato digno, incluyendo brindar la información que requiere el paciente; sin embargo, el desempeño laboral de algunos profesionales de salud significa realizar procedimientos, sin importar lo que siente el paciente²⁵.

Por otro lado, es importante el tipo de lenguaje verbal que emplea la enfermera, dado que esto dará beneficios a la mejoría del paciente²⁵.

2.3.5 Dimensión entorno

Esta parte es muy fundamental ya que va ayudar en el proceso de curación y es que según explica la Nightingale; el ambiente en el que se encuentre el paciente es fundamental para su bienestar y recuperación, entonces se concluye que es labor de la enfermera crear un espacio adecuado para brindar comodidad y confort al paciente²⁶.

Algunos de los factores que pueden incluir en el ambiente son: limpieza, ventilación, iluminación, ruido y temperatura²⁶.

CAPÍTULO III: HIPÓTESIS Y VARIABLES

3.1 Formulación de hipótesis principal y derivada

La investigación no presenta hipótesis.

3.2 Variables y definición operacional

Variable: Percepción del paciente sobre la calidad del cuidado de enfermería.

Comentado [C2]: Revise el formato, identifique cuál es la variable.

DEFINICION CONCEPTUAL DE LA VARIABLE: Es la impresión que el paciente puede percibir con respecto a una atención brindada por el profesional de salud.

DEFINICION OPERACIONAL DE LA VARIABLE: Es la percepción que tiene el paciente sobre la calidad del cuidado brindado en sus dimensiones: interpersonal, técnico y entorno.

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES				
VARIABLE	DEFINICIÓN OPERACIONAL	DIMENSIONES	INDICADORES	ESCALA DE MEDICIÓN
Percepción del paciente sobre la calidad del cuidado de enfermería	Es la percepción que tiene el paciente sobre la calidad del cuidado brindado en sus dimensiones.	Dimensión interpersonal	✓ La enfermera lo saluda cordialmente y con respeto cuando llega a la consulta. ✓ Le satisface que la enfermera lo llame por su nombre. ✓ La enfermera establece una relación de confianza con usted. ✓ Le agrada que la enfermera le preste atención cuando conversa con usted. ✓ La enfermera muestra interés por su estado de salud. ✓ La enfermera incentiva su participación durante su tratamiento. ✓ La enfermera le da consuelo cuando esta afligido porque su vida personal familiar se ve afectada a causa de su enfermedad. ✓ Le molesta que la enfermera le responda de modo descortés a sus preguntas.	ORDINAL

Comentado [C3]: Corresponde en escala de medición. Revise el formato.

		Dimensión técnica	✓ La enfermera le orienta con palabras sencillas sobre su enfermedad. ✓ Le incomoda que la enfermera utilice un lenguaje poco comprensible sobre los cuidados a tener en el hogar. ✓ Le agrada que la enfermera le informe sobre su salud. ✓ Le molesta que la enfermera no le oriente sobre los procedimientos que se realicen en el servicio. ✓ La enfermera le orienta sobre los posibles efectos adversos del tratamiento y como resolverlos. ✓ Le incomoda que la enfermera omita o no le exprese los motivos de la visita a su domicilio. ✓ La enfermera le informa acerca de la muestra de esputo, control médico y quimioprofilaxis a su familia. ✓ La enfermera evalúa mensualmente su peso. ✓ La enfermera le proporciona los envases para su muestra de esputo mensualmente. ✓ La enfermera permanece a su lado y observa mientras toma sus medicamentos. ✓ Le satisface que la enfermera le informe sobre el cambio de fase en su tratamiento. ✓ La enfermera le da folletos sobre la tuberculosis. ✓ La enfermera expresa con palabras sencillas su interés por el cumplimiento de su tratamiento.	ORDINAL
--	--	----------------------	---	----------------

			✓ La enfermera le orienta sobre las consecuencias, en caso de abandonar el tratamiento. ✓ Le agrada que la enfermera le oriente sobre los beneficios del tratamiento.	
		Dimensión entorno	✓ Le agrada el lugar donde toma sus medicamentos porque tiene ventilación natural. ✓ El lugar donde es atendido tiene iluminación natural. ✓ Le satisface el lugar donde recibe su tratamiento porque se encuentra limpio. ✓ Es cómodo el lugar donde es atendido por la enfermera. ✓ El ambiente donde recibe su tratamiento le resulta incómodo.	ORDINAL

CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA

4.1 Diseño metodológico

El presente estudio es de método descriptivo deductivo, enfoque cuantitativo, diseño no experimental, de corte transversal prospectivo.

4.2 Diseño muestral

La población de estudio estará constituida por un total de 80 pacientes con tuberculosis atendidos en el Centro de Salud Max Arias Schreiber.

El muestreo será no probabilístico por conveniencia y la muestra quedará constituida por 66 pacientes que reciben tratamiento antituberculoso en el año 2025.

La fórmula que se utiliza es:

$$n = \frac{N * Z^2 * p * q}{(N - 1) E^2 + Z^2 * p * q}$$

N = Tamaño de muestra

Z = Nivel de confianza = 1.96 (95%)

E = Margen de error = 0.05 (5%)

p y q = Heterogeneidad = 0.50 (50%)

Entonces reemplazando los datos se encuentra:

$$n = \frac{80 * 1.96^2 * 0.50 * 0.50}{(80 - 1) 0.05^2 + 1.96^2 * 0.50 * 0.50}$$

n = 66

Criterios de inclusión

- Pacientes que reciban tratamiento antituberculoso
- Pacientes que acepten y firmen el consentimiento informado.
- Pacientes que se atiendan en el Centro de Salud Max Arias Schreiber.
- Pacientes mayores de 18 años.

Criterios de exclusión

- Pacientes que no rellenen en su totalidad la encuesta.
- Pacientes que no desean participar
- Pacientes de otros Centros de Salud.
- Pacientes menores de 18 años.

4.3 Técnica de recolección de datos

La técnica que se va a utilizar es una entrevista y como instrumento un cuestionario donde se va a evaluar la Percepción del paciente sobre la calidad del cuidado de enfermería en el programa de control de tuberculosis.

El instrumento fue tomado de la investigación "Percepción del paciente con tuberculosis", elaborado por Verónica Lorena Pajuelo Herrera²⁷, Lima – Perú en el año 2013, con una validez de >0.20 y un alfa de Cronbach de 0.78.

En este cuestionario se podrá encontrar: primera parte (presentación y datos generales), segunda parte (instrucciones) y tercera parte por 28 preguntas las cuales están divididas en tres dimensiones: 8 preguntas de dimensión

interpersonal, 15 preguntas de dimensión técnica y 5 preguntas de dimensión entorno.

Teniendo como alternativas de respuesta: siempre, raras veces y nunca.

Para la medición de variables se aplicó la escala de estadios dando así las siguientes puntuaciones.

Rango de puntuación	General	Dimensión interpersonal	Dimensión técnica	Dimensión entorno
Favorable	>81	>25	>44	>15
Medianamente favorable	73 – 80	21 – 24	39 – 43	12 – 14
Desfavorable	<72	<20	<38	<11

Para llevar a cabo la recolección de datos se realizará los siguientes procedimientos:

1. Se va a gestionar el permiso mediante una solicitud dirigida al coordinador de estrategia sanitaria de la Red Diris Lima Centro.
2. Luego se va a solicitar la firma de consentimiento informado a los pacientes atendidos en el Centro de Salud Max Arias Schreiber.
3. Teniendo ya los permisos necesarios, se llevará a cabo la encuesta.

4.4 Técnicas estadísticas para el procesamiento de la información

El procesamiento y análisis de datos será realizado con la aplicación estadística de SPSS 6 y EXCEL, donde se irá seleccionando de acuerdo al total de la muestra, donde se menciona todos los ítems del cuestionario. Después de la elaboración y la presentación de los resultados, se realizarán

tablas para su respectivo análisis e interpretación de acuerdo al objetivo y la variable de estudio.

4.5 Aspectos éticos

En el presente estudio de investigación, se respetará los principios bioéticos que rigen al profesional de enfermería a cumplir los objetivos establecidos.

Autonomía: El paciente decidirá por su propia voluntad de participar o no firmando el consentimiento informado de esta investigación.

Beneficencia: En todo momento se buscará el beneficio del paciente para su pronta mejoría.

No maleficencia: Durante el estudio no se creará ningún tipo de daño al paciente ya que los resultados serán confidenciales.

Justicia: En este caso se respetará las ideas, creencias y costumbres de los pacientes, así mismo el trato será de manera equitativa sin ninguna discriminación alguna.

Comentado [C4]: Mejore la redacción, según cada ítem que corresponde.

CAPÍTULO V. RESULTADOS

5.1. Análisis de información

Los datos obtenidos se codificaron en Excel y se analizaron con SPSS versión 26 para evaluar la percepción del paciente sobre la calidad del cuidado de enfermería, considerando las dimensiones interpersonal, técnica y entorno. Los resultados se clasificaron como favorables, medianamente favorables o desfavorables según los rangos establecidos: en la dimensión interpersonal (>25, 21-24, <20), dimensión técnica (>44, 39-43, <38) y dimensión entorno (>15, 12-14, <11). A nivel general, la percepción global del cuidado de enfermería se consideró favorable (>81), medianamente favorable (73-80) o desfavorable (<72). Este análisis permitió categorizar de manera descriptiva la percepción de los pacientes y ofrecer una visión clara de la calidad del cuidado en el contexto del Programa de Control de Tuberculosis.

Tabla 1

Baremación del instrumento

Criterio	Nivel	Rango
Variable: Percepción del paciente sobre la calidad del cuidado de enfermería	Favorable	[65 - 84>
	Medianamente favorable	[47 - 65>
	Desfavorable	[28 - 47>
Dimensión 1: Dimensión interpersonal	Favorable	[19 - 24>
	Medianamente favorable	[13 - 19>
	Desfavorable	[8 - 13>
Dimensión 2: Dimensión técnica	Favorable	[35 - 45>
	Medianamente favorable	[25 - 35>
	Desfavorable	[15 - 25>
Dimensión 3: Dimensión entorno	Favorable	[12 - 15>
	Medianamente favorable	[8 - 12>
	Desfavorable	[5 - 8>

Nota. Elaboración propia

En cuanto al **objetivo general**, se determinó la percepción del paciente sobre la calidad del cuidado de enfermería en el Programa de Control de Tuberculosis del Centro de Salud Max Arias Schreiber durante el año 2024. Para ello, se evaluaron tres dimensiones fundamentales: interpersonal, técnica y entorno, clasificando la percepción de los pacientes en niveles favorables, medianamente favorables y desfavorables según rangos previamente establecidos.

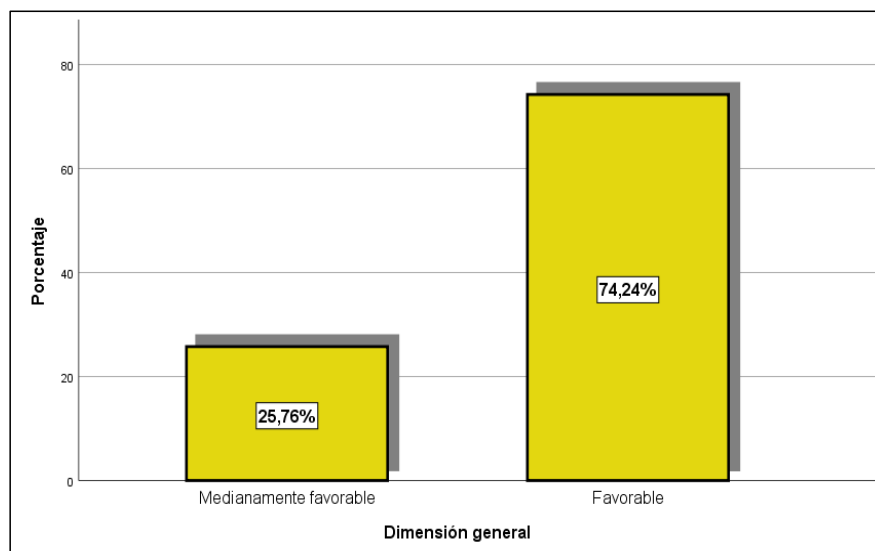
Tabla 2

Variable percepción del paciente sobre la calidad del cuidado de enfermería

Calidad del cuidado de enfermería	Frecuencia	Porcentaje
Medianamente favorable	17	25,8 %
Favorable	49	74,2 %
Total	66	100,0 %

Figura 1

Resultados descriptivos de la variable Percepción del paciente sobre la calidad del cuidado de enfermería



Nota. Elaboración propia a través del software SPSS

Interpretación: En relación con el objetivo de determinar la percepción del paciente sobre la calidad del cuidado de enfermería en el Programa de Control de Tuberculosis del C.S. Max Arias Schreiber, los resultados muestran que, de los 66 pacientes encuestados, el 74,2% percibió la calidad del cuidado como favorable, mientras que el 25,8% la calificó como medianamente favorable y ninguno tuvo una percepción desfavorable (0%). Esto indica que la mayoría de los pacientes considera que la calidad del cuidado de enfermería es satisfactoria, reflejando una atención efectiva y acorde con las necesidades de los pacientes. Sin embargo, la presencia de un cuarto de los encuestados con una percepción medianamente favorable sugiere la necesidad de realizar mejoras en aspectos específicos del cuidado para garantizar una experiencia óptima para todos los pacientes.

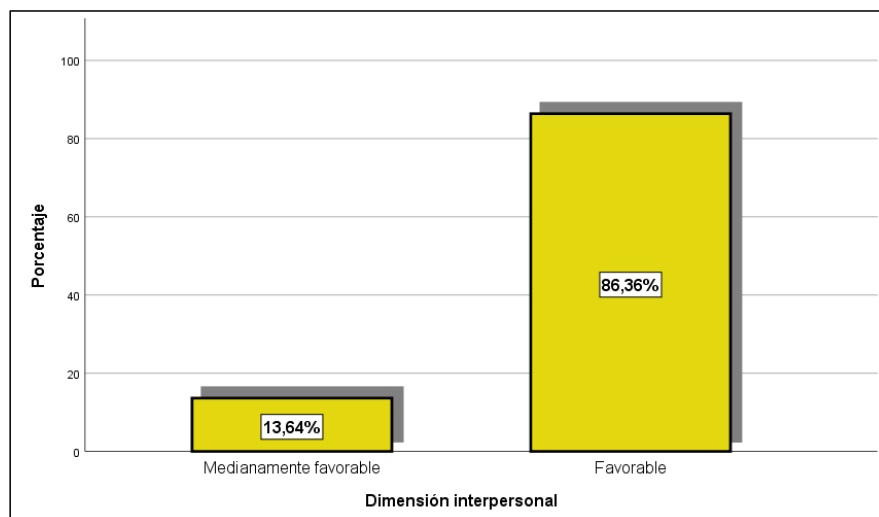
En cuanto al **objetivo específico 1**, se examinó cómo los pacientes perciben la calidad del cuidado de enfermería en términos de la relación interpersonal, enfocándose en la capacidad de los profesionales para establecer una comunicación efectiva, demostrar empatía y generar confianza durante el desarrollo del Programa de Control de Tuberculosis.

Tabla 3
Dimensión interpersonal

Dimensión interpersonal	Frecuencia	Porcentaje
Medianamente favorable	9	13,6 %
Favorable	57	86,4 %
Total	66	100,0 %

Figura 2

Resultados descriptivos de la Dimensión interpersonal



Nota. Elaboración propia a través del software SPSS

Interpretación: Los resultados sobre la dimensión interpersonal del cuidado de enfermería muestran que, de los 66 pacientes encuestados, el 86,4% evaluó esta dimensión como favorable, el 13,6% la calificó como medianamente favorable y ninguno tuvo una percepción desfavorable (0%). Esto indica que, en términos generales, los pacientes tienen una percepción positiva sobre el trato interpersonal brindado por el personal de enfermería, lo que refuerza la calidad del cuidado en esta área. Sin embargo, el grupo que consideró esta dimensión como medianamente favorable señala la posibilidad de optimizar algunos aspectos específicos para mantener un estándar aún más elevado en las interacciones interpersonales.

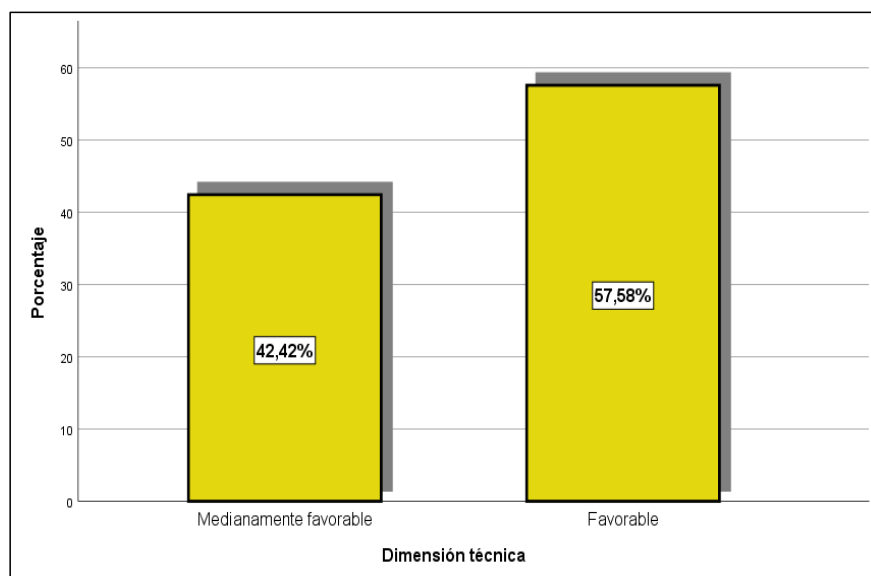
En cuanto al **objetivo específico 2**, se evaluó cómo los pacientes perciben la calidad del cuidado de enfermería en términos de su dimensión técnica, considerando aspectos relacionados con la precisión en la ejecución de los

procedimientos, el conocimiento aplicado y el cumplimiento de los estándares de calidad en el contexto del Programa de Control de Tuberculosis.

Tabla 4
Dimensión técnica

Dimensión técnica	Frecuencia	Porcentaje
Medianamente favorable	28	42,4 %
Favorable	38	57,6 %
Total	66	100,0 %

Figura 3
Resultados descriptivos de la Dimensión técnica



Nota. Elaboración propia a través del software SPSS

Interpretación: En relación con el objetivo de identificar la percepción del paciente sobre la calidad del cuidado de enfermería en su dimensión técnica, los resultados muestran que, de los 66 pacientes encuestados, el 57,6% percibió esta dimensión como favorable, mientras que el 42,4% la consideró

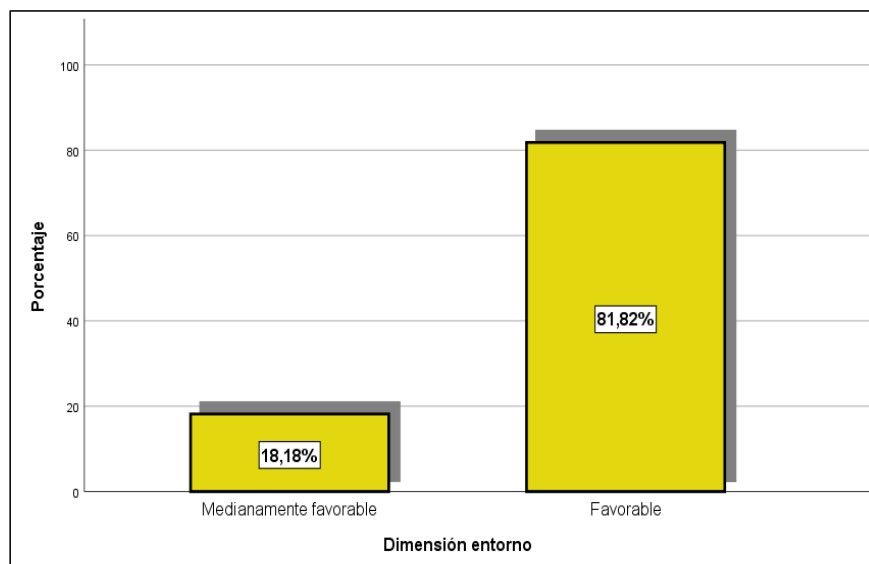
medianamente favorable y ninguno tuvo una percepción desfavorable (0%). Esto indica que, aunque más de la mitad de los pacientes valoran positivamente las competencias técnicas del personal de enfermería en el Programa de Control de Tuberculosis, existe una proporción considerable que percibe estas competencias como medianamente favorables. Esto señala la importancia de fortalecer la capacitación y los procesos técnicos para asegurar que las expectativas de todos los pacientes sean satisfechas y así mejorar la percepción global de esta dimensión.

En cuanto al objetivo **específico 3**, se analizó la percepción de los pacientes sobre la calidad del cuidado de enfermería en relación con su dimensión entorno, enfocándose en la valoración de las condiciones físicas, la limpieza, la comodidad y la adecuación de los espacios donde se brinda el servicio dentro del Programa de Control de Tuberculosis.

Tabla 5
Dimensión entorno

Dimensión entorno	Frecuencia	Porcentaje
Medianamente favorable	12	18,2 %
Favorable	54	81,8 %
Total	66	100,0 %

Figura 4
Resultados descriptivos de la Dimensión entorno



Nota. Elaboración propia a través del software SPSS

Interpretación: En cuanto al objetivo de identificar la percepción del paciente sobre la calidad del cuidado de enfermería en su dimensión entorno, los resultados reflejan que, de los 66 pacientes encuestados, el 81,8% calificó esta dimensión como favorable, mientras que el 18,2% la consideró medianamente favorable, y ninguno tuvo una percepción desfavorable (0%). Esto demuestra que la mayoría de los pacientes percibe de manera positiva las condiciones del entorno en el cual reciben atención, lo que incluye factores como la comodidad, limpieza y organización del espacio. Sin embargo, el grupo que tiene una percepción medianamente favorable resalta la necesidad de realizar ajustes específicos en el entorno para optimizar la experiencia del cuidado de enfermería y lograr una percepción aún más satisfactoria.

CRONOGRAMA

Nº	Actividades	Meses					
		Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	noviembre
1	Identificación y formulación del problema	X					
2	Revisión de las fuentes de información	X					
3	Redacción de objetivos y operacionalización de las variables	X					
4	Determinación del diseño de investigación		X				
5	Determinación del marco muestral		X				
6	Selección de los estadígrafos a utilizar		X				
7	Recolección de datos			X	X		
8	Organización y procesamiento de los datos				X		
9	Análisis e interpretación de los resultados				X		
10	Redacción del informe					X	
11	Presentación del informe						X

PRESUPUESTO

Tipo	Servicios	Unidad	Costo unidad	Monto total
Recursos humanos	Investigador			
	Personal para la tabulación	6 horas	15	90.00
	Análisis estadístico			500.00
	Traducción del documento en ingles	20 hojas	10	200.00
	Sub total			790.00
Adquisición de bienes	Material de escritorio (hojas, tónér de impresión, lapicero)			100.00
	Incentivo para participantes	30	15	450.00
	Sub total			550.0
Servicios	Internet			30.00
	Impresión de cuestionarios y fotocopia de documentos			120.00
	Movilidad			100.00
	Sub total			250.0
Total, general				1590.0

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Pérez MM. Tuberculosis: Fisiopatología, signos y síntomas, diagnóstico, tratamiento, epidemiología, medidas de protección para el personal sanitario y cuidados de enfermería [Internet]. Rev. Elec. de PortMed; 2022 [citado 7 de agosto de 2024]; Vol. XVII; nº 2; 108. Disponible de: <https://www.revista-portalesmedicos.com/revista-medica/tuberculosis-fisiopatologia-signos-y-sintomas-diagnostico-tratamiento-epidemiologia-medidas-de-proteccion-para-el-personal-sanitario-y-cuidados-de-enfermeria/>
2. Organización mundial de la salud [Internet]. Ginebra: OMS; c2023. Tuberculosis; 07 noviembre 2023. [citado 10 de julio de 2024]. Disponible de: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/tuberculosis>
3. Organización panamericana de la salud [Internet]. Washintog.OPS; c2021. Tuberculosis en las Américas. [citado 10 de julio 2024]. Disponible de: <https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/57084/9789275326497spa.pdf?sequence=11&isAllowed=y>
4. Ministerio de Salud [Internet]. Lima: MINSA; c2022. Situación Epidemiológica de la TBC en el Perú; 30 junio 2022. [citado 10 de julio de 2024]. Disponible de: <https://www.dge.gob.pe/portal/docs/tools/teleconferencia/2022/SE272022/03.pdf>

5. Juárez-García A, Hernández-Mendoza E. Intervenciones de enfermería en la salud en el trabajo. Rev Enferm IMSS [Internet]. 2010 [citado 10 de julio 2024];18(1):23-30. Disponible de: https://www.researchgate.net/profile/Arturo-Juarez-Garcia/publication/267833082_Intervenciones_de_enfermeria_en_la_salud_en_el_trabajo/links/545ef6970cf2c1a63bfc265e/Intervenciones-de-enfermeria-en-la-salud-en-el-trabajo.pdf
6. Organización mundial de la salud [Internet]. Ginebra: OMS; c2021. Calidad de la atención. [citado 10 de julio de 2024]. Disponible de: <https://www.who.int/es/health-topics/quality-of-care>
7. Gestión sanitaria: Aportar calidad al sector sanitario [Internet]. Organización Internacional de Normalización (ISO); c2024. Disponible de: <https://www.iso.org/es/sanidad/gestion-sanitaria>
8. Olivares SN. Percepción del paciente con tuberculosis sobre la interrelación enfermera paciente en un Centro de Salud de Lima, 2022 [tesis de licenciatura en Internet]. Perú: Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 2024 [citado 11 de julio de 2024]. 80 p. Disponible de: <https://cybertesis.unmsm.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/2777597d-8480-4a0f-a929-f0fcf139398e/content>
9. García MJ. Percepción de los pacientes en tratamiento de tuberculosis acerca del cuidado que brinda el profesional de enfermería en la estrategia sanitaria nacional de prevención y control de tuberculosis del Centro de Salud Materno Infantil, Los Sureños, Puente Piedra – 2020 [tesis de licenciatura en Internet]. Perú: Universidad César Vallejo: 2020

- [citado 30 de septiembre del 2024]. 60 p. Disponible de:
<https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/5772>
10. Condori CM. Percepción del paciente sobre calidad de atención del equipo del programa de control de tuberculosis del Hospital Jerusalén periodo 2019 [tesis de maestría]. Perú: Universidad Cesar Vallejo: 2020 [citado 30 de septiembre del 2024]. 55 p. Disponible de:
<https://hdl.handle.net/20.500.12692/50073>
11. Vásquez CJ. Percepción de la calidad de atención del programa de tuberculosis DOTS de pacientes adultos del Centro de Salud Tipo C La Troncal. Mayo – junio 2023 [tesis de maestría en Internet]. Ecuador: Pontificia Universidad de Ecuador: 2023 [citado 30 de septiembre del 2024]. 86 p. Disponible de:
<https://repositorio.puce.edu.ec/items/f205293d-3551-4d56-8ed1-ff75280bab2c>
12. Mariani J, Ferrante D, Battistella G, Langsam M, Pérez F, Macchia A. Evaluación del primer nivel de atención para el control de la tuberculosis en Buenos Aires, Argentina. Rev Panam Salud Publica [Internet]. 2020 [citado 30 de septiembre del 2024]; 44 (e156). Disponible de:
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7745725/>
13. Hildegard Peplau: biografía y teoría de las relaciones [Internet]. Lifeder; c2022. [citado 13 de julio de 2024] Disponible de:
<https://www.lifeder.com/hildegard-peplau-biografia-teoria/>

14. Lavín Meruelo L. La entrevista en enfermería: una habilidad comunicativa [trabajo fin de grado en internet]. España: Universidad DE CANTABRIA: Escuela Universitaria de Enfermería “Casa de Salud Valdecilla”, 2013. 39. [citado 13 de julio de 2024]; Disponible de: <https://www.enfermeriaaps.com/portal/wp-content/uploads/2014/10/La-entrevista-en-Enfermer%C3%ADa.-Una-habilidad-Comunicativa.-2013.pdf>
15. Nardell E. Tuberculosis [internet]. Manual MSD Versión para profesionales; c2022 [citado 13 de julio de 2024] Disponible de: <https://theunion.org/sites/default/files/2020-08/Manejo-de-la-Tuberculosis-Septima-edicion.pdf>
16. Guixá-Piñol M, Alarcón-Sisamón S, Viñuales-Aranda M. La tuberculosis: Artículo monográfico. RSI [internet]. 2023 [citado 16 de julio de 2024]; Disponible de: <https://revistasanitariadeinvestigacion.com/la-tuberculosis-articulo-monografico/>
- Corregir con et al
17. GOB.PE [internet]. Perú: GOB.PE; c2024 ¿Qué es la tuberculosis (TB)? Diagnostico; 12 julio 2024. [citado 16 de julio de 2024]. Disponible de: <https://www.gob.pe/63294-pruebas-de-diagnostico-para-confirmar-la-tuberculosis>
18. Arias F, Herrera T. Nuevos métodos para el diagnóstico de la tuberculosis. Rev. chil. enferm. Respir [internet]. 2016 [citado 16 de julio de 2024]; 32(4): 254–259. Disponible de: <https://revchilenfermrespir.cl/index.php/RChER/article/view/255>

19. Nardell E. Tuberculosis Extrapulmonar [internet]. Manual MSD Versión para profesionales; c2022 [citado 16 de julio de 2024] Disponible de: <https://www.msdmanuals.com/es-mx/professional/enfermedades-infecciosas/micobacterias/tuberculosis-extrapulmonar>
20. Dlodlo RA, Brigden G, Heldal E, Allwood B, Chiang C-Y, Fujiwara PI et al. Manejo de la tuberculosis [Internet]. The Union; 2019. [citado 16 de julio de 2024]; Disponible de: <https://theunion.org/sites/default/files/2020-08/Manejo-de-la-Tuberculosis-Septima-edicion.pdf>
21. Mary Dulcinia Lugo. Tipos de percepción en psicología [Internet]. Psicología Online; c2022. Disponible de: [Tipos de percepción en psicología - Definición, clasificación y características \(psicologia-online.com\)](https://psicologia-online.com/Tipos-de-percepcion-en-psicologia-Definicion-clasificacion-y-caracteristicas/)
22. Cobos D. Gestión de la calidad de los cuidados en enfermería. Rev. Elec. de PortMed. [internet]. 2019 [citado 16 de julio de 2024]; 14 (24): 622. disponible de: <https://www.revista-portalesmedicos.com/revista-medica/gestion-de-la-calidad-de-los-cuidados-en-enfermeria/>
23. Milián N. La importancia de la calidad de los cuidados de enfermería en las instituciones sanitarias [Internet]. Revista Sanitaria de Investigación; 2023. [citado 16 de julio de 2024]; Disponible de: <https://revistasanitariadeinvestigacion.com/la-importancia-de-la-calidad-de-los-cuidados-de-enfermeria-en-las-instituciones-sanitarias/>

24. Elers Mastrapa Y, Gibert Lamadrid M. Relación enfermera-paciente una perspectiva desde las teorías de las relaciones interpersonales. Rev. Cub. Enf. [internet]. 2016 [citado 16 de julio]; 32(4): 126-136 <http://scielo.sld.cu/pdf/enf/v32n4/enf19416.pdf>
25. Ramírez P, Müggenburg C. Relaciones personales entre la enfermera y el paciente. Enferm. Univ. [internet]. 2015 [citado 15 de octubre de 2024]; 12 (3): 134 -143. Disponible de: <http://www.revista-enfermeria.unam.mx/ojs/index.php/enfermeriauniversitaria/article/view/132/128>
26. Teoría del Entorno de Florence Nightingale: Descubre su Impacto en la Salud [internet]. Teoría Online; c2021. [citado 18 de julio de 2024]; Disponible de: <https://teoriaonline.com/florence-nightingale-teoria-del-entorno/>
27. Pajuelo Herrera V. Percepción del paciente con tuberculosis sobre la calidad de atención que brinda el profesional de enfermería en la estrategia sanitaria de prevención y control de tuberculosis Hospital de Barranca [trabajo de titulación en Internet]. Perú: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2013 [citado 18 de julio de 2024]. 107 P. Disponible de: <https://cybertesis.unmsm.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/56067370-1274-4d30-bd46-77a8f321a755/content>

ANEXOS

ANEXO A: PERCEPCIÓN DEL PACIENTE SOBRE LA CALIDAD DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS DEL C.S MAX ARIAS SCHREIBER 2024

1. INSTRUMENTO

Buenos días sr. (a), quien se dirige a ustedes, Elena Duran Landa, Bachiller en enfermería, de la Universidad San Martin de Porres, donde estoy realizando un estudio de investigación sobre: Percepción del paciente sobre la calidad del cuidado de Enfermería en el Programa de Control de Tuberculosis del C.S Max Arias Schreiber 2024, con la finalidad de mejorar la atención durante su tratamiento, por lo que solicito su colaboración, respondiendo honestamente el siguiente cuestionario, recalcando que esta información es de carácter anónima y confidencial, de ante mano agradezco su participación:

I. DATOS GENERALES

EDAD

SEXO

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

PRIMARIA

SECUNDARIA

SUPERIOR

- II. A continuación, se presenta una serie de preguntas con 3 alternativas posibles de las cuales marcara con un aspa (x) la respuesta que usted crea conveniente:

SIEMPRE (3) **RARAS VECES (2)** **NUNCA (1)**

(F) favorable **(MF)** medianamente favorable **(D)** desfavorable

III. CUESTIONARIO

PROPOSICIONES	S	RV	N
1. La enfermera lo saluda cordialmente y con respeto cuando llega a la consulta.			
2. Le satisface que la enfermera lo llame por su nombre.			
3. La enfermera establece una relación de confianza con usted.			
4. Le agrada que la enfermera le preste atención cuando conversa con usted.			
5. La enfermera muestra interés por su estado de salud.			
6. La enfermera incentiva su participación durante su tratamiento.			
7. La enfermera le da consuelo cuando esta afligido porque su vida personal familiar se ve afectada a causa de su enfermedad.			
8. Le molesta que la enfermera le responda de modo descortés a sus preguntas.			
9. La enfermera le orienta con palabras sencillas sobre su enfermedad.			
10. Le incomoda que la enfermera utilice un lenguaje poco comprensible sobre los cuidados a tener en el hogar.			
11. Le agrada que la enfermera le informe sobre su salud.			
12. Le molesta que la enfermera no le oriente sobre los procedimientos que se realicen en el servicio.			
13. La enfermera le orienta sobre los posibles efectos adversos del tratamiento y como resolverlos.			
14. Le incomoda que la enfermera omita o no le exprese los motivos de la visita a su domicilio.			
15. La enfermera le informa acerca de la muestra de esputo, control médico y quimioprofilaxis a su familia.			
16. La enfermera evalúa mensualmente su peso.			
17. La enfermera le proporciona los envases para su muestra de esputo mensualmente.			
18. La enfermera permanece a su lado y observa mientras toma sus medicamentos.			
19. Le satisface que la enfermera le informe sobre el cambio de fase en su tratamiento.			
20. La enfermera le da folletos sobre la tuberculosis.			
21. La enfermera expresa con palabras sencillas su interés por el cumplimiento de su tratamiento.			
22. La enfermera le orienta sobre las consecuencias, en caso de abandonar el tratamiento.			
23. Le agrada que la enfermera le oriente sobre los beneficios del tratamiento.			
24. Le agrada el lugar donde toma sus medicamentos porque tiene ventilación natural.			
25. El lugar donde es atendido tiene iluminación natural.			
26. Le satisface el lugar donde recibe su tratamiento porque se encuentra limpio.			
27. Es cómodo el lugar donde es atendido por la enfermera.			
28. El ambiente donde recibe su tratamiento le resulta incómodo.			

ANEXO B: PROTOCOLO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES

Institución:

Universidad San Martín de Porres

Investigadora:

Duran Landa Elena

Título del estudio:

“PERCEPCIÓN DEL PACIENTE SOBRE LA CALIDAD DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS DEL CENTRO DE SALUD MAX ARIAS SCHREIBER 2024”

Propósito del estudio:

Se le invita a usted a participar en el estudio, cuyo objetivo es: Determinar la percepción del paciente sobre la calidad del cuidado de Enfermería en el Programa de Control de Tuberculosis del Centro de Salud Max Arias Schreiber.

Procedimientos:

Si usted accede participar de este estudio tendrá que realizar lo siguiente:

- Leer atentamente el documento.
- Responder todas las preguntas formuladas en la encuesta.
- Firmar el consentimiento informado.
- La encuesta puede tardar unos 20 a 30 minutos y los resultados serán anónimos respetando la confidencialidad.

Riesgos:

No existe ningún riesgo al que puede estar expuesto ya que solo se pedirá responder el cuestionario. Su participación en el estudio es voluntaria.

Costos e incentivos:

Su participación es totalmente gratis, del mismo modo no habrá medicamentos o incentivos económicos a cambio.

Confidencialidad:

La información que nos brinda a través del cuestionario será guardada con códigos por lo que se hará mención su nombre, si los resultados de este estudio son publicados no mostraremos su identificación además personas ajenas al estudio no tendrán acceso a la información.

Derechos del participante:

Si usted se siente incómodo durante el cuestionario podrá retirarse en cualquier momento o no participar del estudio, por lo contrario, si participa y tiene alguna duda o molestia no dude en preguntar al personal de estudio.

Consentimiento:

Acepto participar voluntariamente en este estudio, comprendo que cosas pueden pasar si participo también entiendo que puedo decidir no participar o, aunque haya aceptado me puedo retirar en cualquier momento. Recibiré una copia firmada de este consentimiento.

Nombre completo del participante
Fecha

Firma

Nombre del Investigador
Fecha

Firma

ANEXO: MATRIZ DE CONSISTENCIA

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	OBJETIVOS	VARIABLE	DISEÑO METODOLOGICO
Problema general ¿Cuál es la percepción del paciente sobre la calidad del cuidado de Enfermería en el Programa de Control de Tuberculosis del CS Max Arias Schreiber 2024? Problemas específicos ¿Cuál es la percepción del paciente sobre la calidad del cuidado de Enfermería en el Programa de Control de Tuberculosis en su dimensión interpersonal del CS Max Arias Schreiber 2024? ¿Cuál es la percepción del paciente sobre la calidad del cuidado de Enfermería en el Programa de Control de Tuberculosis en su dimensión técnica del CS Max Arias Schreiber 2024? ¿Cuál es la percepción del paciente sobre el cuidado de Enfermería en el Programa de Control de Tuberculosis en su dimensión entorno del CS Max Arias Schreiber 2024?	Objetivo general Determinar la percepción del paciente sobre la calidad del cuidado de Enfermería en el Programa de Control de Tuberculosis del CS Max Arias Schreiber 2024. Objetivos específicos Identificar la percepción del paciente sobre la calidad del cuidado de Enfermería en el Programa de Control de Tuberculosis en su dimensión interpersonal en el CS Max Arias Schreiber 2024. Identificar la percepción del paciente sobre la calidad del cuidado de Enfermería en el Programa de Control de Tuberculosis en su dimensión técnica en el CS Max Arias Schreiber 2024. Identificar la percepción del paciente sobre la calidad del cuidado de Enfermería en el Programa de Control de Tuberculosis en su dimensión entorno en el CS Max Arias Schreiber 2024.	Percepción del paciente sobre la calidad del cuidado de enfermería.	Tipo y diseño de investigación Según el método: deductivo Según el enfoque: cuantitativo Según el tipo de investigación: básica Según el diseño: no experimental Según el corte: transversal - prospectivo Según el nivel o alcance: descriptivo